

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario de Salud SF-36 (SF-36)

Eje IV • Versión de trabajo: 11 de septiembre de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Cuestionario de Salud SF-36
Sigla	SF-36
Autores	Ware, J. E., & Sherbourne, C. D.
Año	1992
Eje	EJE IV - FUNCIONAMIENTO, ADAPTACIÓN Y RECURSOS
Constructo principal	Calidad de vida
Población	Adultos (general y pacientes médicos/psiquiátricos)
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Alonso, Prieto y Antó, 1995). Protocolo en español incluido (Protocolo.pdf).
Acceso/licencia	Publicable. Protocolo en español (Protocolo.pdf, formulario difundido por SECOT). Versión inglesa RAND 36-Item Health Survey 1.0 de dominio público (RAND36_English_Protocolo.pdf).
Nota curatorial de derechos	SF-36v2 es comercial/licenciado por QualityMetric; no reproducir formularios.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Calidad de vida. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	8 dominios (Función física, Rol físico, Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocional, Salud mental). Se agrupan en un Componente Físico y un Componente Mental.

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos (general y pacientes médicos/psiquiátricos)
Número de ítems	36 ítems.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Opciones según ítem: 5 (ítems 1, 2, 20, 22, 33-36), 3 (ítems 3-12), 2 (ítems 13-19) y 6 (ítems 21, 23-31). Ítem 32: 6 opciones en el protocolo (SECOT); 5 en la versión de Alonso et al. y en la clave RAND.
Administración	Autoadministrada. Instrucción del protocolo: «Marque una sola respuesta».
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/ subescalas	8 dominios (Función física, Rol físico, Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocional, Salud mental). Se agrupan en un Componente Físico y un Componente Mental.
Ítems	36 ítems.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Opciones según ítem: 5 (ítems 1, 2, 20, 22, 33-36), 3 (ítems 3-12), 2 (ítems 13-19) y 6 (ítems 21, 23-31). Ítem 32: 6 opciones en el protocolo (SECOT); 5 en la versión de Alonso et al. y en la clave RAND.
Relación ítem-dimensión	Según la clave RAND (rand.org): Función física 3-12; Rol físico 13-16; Rol emocional 17-19; Vitalidad 23, 27, 29, 31; Salud mental 24, 25, 26, 28, 30; Función social 20, 32; Dolor corporal 21, 22; Salud general 1, 33-36. El ítem 2 no integra ninguna escala.
Ítems invertidos	Ver la tabla de recodificación del Protocolo.pdf (método RAND).

5 Sistema de puntuación

Se transforman en puntuaciones de 0 (peor salud) a 100 (mejor salud) por cada dominio.

Regla de corrección	Cada ítem se recodifica a 0-100 y se promedian los ítems de cada escala (método RAND 36-Item Health Survey 1.0, ver Protocolo.pdf). A mayor puntuación, mejor estado de salud.
Ítems invertidos	Ver la tabla de recodificación del Protocolo.pdf (método RAND).
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Dimensional. Un perfil global del impacto de la enfermedad mental o física en el funcionamiento.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

El cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) más documentado del mundo.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	El cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) más documentado del mundo.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí, traducción española validada (Alonso, Prieto y Antó, 1995); protocolo en español incluido.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Versión española de Alonso, Prieto y Antó (IMIM), en el formulario difundido por SECOT.
Población/país	Adultos (general y pacientes médicos/psiquiátricos)
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Calidad de vida en Adultos (general y pacientes médicos/psiquiátricos), condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Ware, J. E., & Sherbourne, C. D.; 1992.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Alonso et al., 1995)
- Trazabilidad local: Protocolo.pdf (español, SECOT) y RAND36_English_Protocolo.pdf (inglés, rand.org).

11 Limitaciones

- SF-36v2® es una edición comercial distinta (QualityMetric/Optum): sus formularios y reglas no se aplican a esta versión.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- La clave incluida es la de RAND; puede diferir de la del manual de la versión española en Dolor corporal y Salud general.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Calidad de vida
Población	Adultos (general y pacientes médicos/psiquiátricos)
Estructura	Catálogo: 36 ítems.; 8 dominios (Función física, Rol físico, Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocional, Salud mental). Se agrupan en un Componente Físico y un Componente Mental.. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Recodificación 0–100 por ítem y promedio por escala (método RAND). A mayor puntuación, mejor estado de salud.
Interpretación	Dimensional. Un perfil global del impacto de la enfermedad mental o física en el funcionamiento.
Estado de fuentes	Protocolo.pdf (español, SECOT) y RAND36_English_Protocolo.pdf (inglés, rand.org).
Estado de uso	Verificado y publicable: protocolo en español e inglés.
Decisión técnica	Ficha y protocolo en español habilitados para publicación. Se conserva la versión inglesa RAND-36 como referencia.
Alerta de versión	Ítem 32: el protocolo (SECOT) tiene 6 opciones; la versión de Alonso et al. y la clave RAND usan 5.

14 Referencias APA 7

Ware, J. E., & Sherbourne, C. D. (1992). Cuestionario de Salud SF-36.

Alonso, J., Prieto, L., & Antó, J. M. (1995). La versión española del SF-36 Health Survey (Cuestionario de Salud SF-36): un instrumento para la medida de los resultados clínicos. *Medicina Clínica*, 104(20), 771–776.

<https://www.qualitymetric.com/health-surveys/the-sf-36v2-health-survey/>

[https://doi.org/10.1016/0022-3999\(92](https://doi.org/10.1016/0022-3999(92)

[https://doi.org/10.1016/S0025-7753\(05](https://doi.org/10.1016/S0025-7753(05)

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.